

К.В.Артемов, И.Р.Хусаинова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Психологическое сопровождение онкологических больных

Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам стратегии психотерапевтических и психологических подходов в сопровождении онкобольных, на разных этапах. Приведены примеры применения психотерапии в сочетании с психофармакологической поддержкой пациентов с онкозаболеваниями. Рекомендованы основные направления для выработки стратегий психологической работы в условиях онкологического отделения.

Ключевые слова: Онкология, онкопсихология, психотерапия, качество жизни.

В настоящее время, уже ни у кого не вызывает сомнений факт, что в практической деятельности медицинского работника, вопрос особенностей психологического подхода к различным контингентам больных является актуальным. Характер и особенности того или иного заболевания так или иначе, накладывает, ограничивающий жизнедеятельность, отпечаток на качество жизни и переживание своего страдания больным, и формирует у него своеобразное отношение к себе, к болезни, к её прогнозу, и лечебному процессу. От этого отношения зависит эффективность лечебных мероприятий, врачебных назначений, и, в конечном счёте, качество жизни больного и исход болезни. Онкологические больные, в этом случае, значительно выделяются из многих других групп больных ввиду того, что в общественном сознании, до сих пор распространено, во многих случаях, устаревшее не критичное, и сильно обобщённое мнение о фатальности и неизлечимости онкозаболеваний. Это связано с недостаточной осведомлённостью широкого круга населения относительно новых средств и методов профилактики, диагностики и лечения, известных, лишь в основном, в кругу узких специалистов, практикующих непосредственно в онкологии.

Современные теории личности включают в себя кроме познавательной, поведенческой и эмоционально-волевой сфер, «систему психологической защиты», призванную ограждать душу от болезненных переживаний и осознания порою очевидных фактов, сигнализирующих о тех или иных угрозах физическому, душевному и социальному благополучию, а порою и жизни [1]. Это происходит или путём их иррационального отрицания, изменения значимости, или замены смыслов понятий в сознании. В некоторых случаях, происходит вытеснение неприятных переживаний из осознания любыми другими событиями или мыслями. Иногда разум выстраивает очевидным неприятным фактам собственное псевдорациональное «теоретическое» обоснование, уводящее внимание человека в сторону, от реальной проблемы, и придавая ей совсем иное значение. Всё это приводит к снижению психического напряжения за счёт смещения фокуса внимания с проблемы на что-нибудь другое, без реальной попытки её решения. Психологический контакт с таким больным и его родственниками бывает

зачастую, действительно нелёгок и сопряжен со значительным психоэмоциональным напряжением персонала, также, вынужденного практически ежедневно находиться в условиях хронического стресса [2].

Второй стратегией человеческой психики, при возникновении проблемных и стрессовых ситуаций, являются механизмы совладания с ними. В отличие от иррациональных, неосознаваемых, и зачастую контрпродуктивных стратегий психологической защиты, они направлены на мобилизацию ресурсного потенциала личности, направленного на реалистичное решение и преодоление проблемы. [1] Поэтому знание особенностей психического и психологического состояния на тех или иных этапах контакта с больным позволяет предупредить возможные психогенные влияния онкологических заболеваний и оптимизировать лечебный процесс. Психотравмирующий фактор онкологического диагноза зачастую воспринимается больным как в принципе неразрешимый с учетом коллективно-бессознательных представлений о неизлечимости опухолевых заболеваний. Связанная с ним угроза для жизни запускает мощный каскад переживаний, основанных на эмоциях, относящихся к базовому инстинкту самосохранения в основе которого лежит страх смерти. Он, по сути, является мотором в основе всех форм психической и поведенческой активности и является пусковым для прочих жизненно важных форм инстинктивной и социальной деятельности.

Для выработки стратегии психотерапевтических и психологических подходов к онкобольным, на разных этапах, удобно их разделить на следующие периоды [3]:

- поликлинический диагностический,
- этап «поступления в клинику»,
- предоперационный (предлечебный),
- послеоперационный,
- этап выписки,
- катамнестический.

Для поликлинического (диагностического) этапа, начинающегося с первых контактов больного с онкологической службой, а часто с направления пациента врачами к онкологам для осмотра и решения вопроса о необходимости госпитализации и оперативного лечения, характерным считается тревожно-депрессивный синдром. Типичным является общее беспокойство, выраженная тревога, иногда достигающая степени страха, ощущение полнейшей безнадежности, бесперспективности существования, мысли о неизбежной скорой и мучительной смерти. У тех пациентов, преморбид которых отличается чертами стеничности и активности в клинической картине обычно преобладают тревога и страх, в то время как у пассивных, астеничных субъектов на первый план выступает депрессивная симптоматика. На этом этапе больной нуждается в неформальной эмоциональной поддержке

со стороны врача, медсестры, родственников, призванной снизить интенсивность страха путем вселения надежды на возможность благоприятного исхода заболевания. В этом немаловажную роль играют примеры успешного достижения многолетних ремиссий болезни на фоне радикальных хирургических вмешательств и применения новейших химиотерапевтических препаратов, успехи лучевой терапии и совершенствования реабилитационных технологий. Всё это можно отнести и к санитарно-просветительной работе, технологии которой нужно активно внедрять уже «в коридоре» поликлиники, где больной ожидает приёма врача. Приветливое, доброжелательное и спокойное отношение к больному на этом этапе способствует к формированию у него надежды на то что «здесь мне действительно могут помочь».

Второе место по частоте возникновения на «диагностическом» этапе принадлежит дисфорическому синдрому, проявляющемуся в тоскливо-злобном настроении. Больные становятся мрачными, раздражительными, иногда без малейшего повода наблюдаются вспышки ярости, гнева, злобы, которые могут сопровождаться агрессией, направленной на ближайшее окружение (семью, сотрудников по работе, а также медицинский персонал). Зачастую за таким фасадом злобы и агрессии скрываются тревога и страх. Дисфорические расстройства обычно развиваются у лиц, преморбид которых характеризовался чертами возбудимости, взрывчатости, безудержности. С учетом этого, необходимо быть готовым к, порой, чрезмерной требовательности больных к персоналу, и к возможным конфликтам «на ровном месте», не вовлекаясь при этом в конфронтацию с позиций обиденной бытовой ссоры. Следует всегда помнить, что в основе провоцирующего и конфликтного поведения у многих онкологических больных лежит глубочайшее чувство отчаяния и страха, замешательство и ощущение агрессии ко всему бытию, допустившему по отношению к ним смертельную «несправедливость» в виде онкологического заболевания. Категорически неверно вступать с такими больными в спор, или пытаться их «поставить на место» - это может привести, в итоге, либо к отказу от лечения вообще, либо запустить долговременные конфликты и разбирательства в различных инстанциях, дезорганизующие надолго работу всего ЛПУ. Порой, чтобы сгладить такие эмоциональные выплески, больного достаточно, по-человечески, просто пожалеть и выразить ему сочувствие и понимание того, насколько тяжело переживать то, что он испытывает.

Третье место по частоте возникновения принадлежит тревожно-ипохондрической и астено-ипохондрической симптоматике. Первые из этих реакций характеризуются тревожным напряжением с постоянной фиксацией внимания на самочувствии, в особенности на ощущениях. Больные все время ищут и «находят» особые «неполадки» в организме, обычно ссылаясь при этом на какие-то неотчетливые, неопределенные ощущения, которые ими интерпретируются как катастрофически быстрое распространение опухоли по всему телу, безнадежная запоздалость диагностики и т.п. В данном случае бывает достаточно просто внимательно отнестись к таким жалобам. Следует выслушать больного, задать уточняющие

вопросы об их характере, но сопоставить их с менее значимыми, чем основное онкологическое заболевание болезнями, которые следует соотнести с высоким уровнем стресса, который переживает больной. Таким образом, можно в значительной мере «обесценить» ипохондрическую фиксацию больного, который внимательно «прислушивается» к любым неприятным ощущениям.

На следующем этапе — «поступления в клинику» происходит некоторое снижение тяжести (интенсивности) переживаний. Это в существенной мере связано с построением компенсаторной системы психологической защиты типа: «Я болен, возможно, у меня даже рак, но теперь я нахожусь в специальной больнице под наблюдением квалифицированных врачей, которые сделают все, чтобы мне помочь». На этом этапе может проявляться любая симптоматика из всех описанных выше, как: тревожно-депрессивная, дисфорическая, тревожно-ипохондрическая, обсессивно-фобическая, и все рекомендации для лиц, контактирующих с больным, указанные выше остаются актуальными и на этом этапе. В это время, необходимо учитывать возможность внезапных «взрывов отчаяния» под влиянием наплыва навязчивых мыслей о напрасности усилий перед лицом неизлечимого заболевания, которые могут произойти на фоне ожидания болезненных диагностических и лечебных процедур. Следствием таких острых невротических реакций могут быть отказы от лечения, от оперативных вмешательств, благодаря которым больному, порой, можно сохранить здоровье и жизнь, или в случаях паллиативных вмешательств в значительной мере облегчить его страдания, и выиграть время для решения значимых для него вопросов, которые он намеревается решить самостоятельно. В случае таких реакций имеет смысл ободрить больного своим присутствием, молчаливым вниманием, уместным прикосновением, дающим ему понять, что вы не безучастны к его судьбе и он в этот момент не один «перед ликом смерти». Из того что можно сказать больному в таких случаях, наилучшим является напоминание о том, что «если есть хоть один шанс повлиять на ситуацию в свою пользу, то лучше его использовать, чем жалеть потом о том, что этот шанс был упущен». При обнаружении такого состояния, больного следует направить к психиатру-психотерапевту, или к психологу в зависимости от штатного расписания ЛПУ. Резкий подъем интенсивности психогенных переживаний отмечается на следующем этапе — предоперационном (предлечебном). В рамках тревожно-депрессивного синдрома преобладающим становится страх возможной гибели в процессе операции в сочетании со страхом самого заболевания. В этот период имеет смысл применение психотерапии в сочетании с психофармакологической поддержкой пациента в зависимости от ведущего синдрома. Например, в АРОД наблюдался отчетливый, быстрый и стойкий положительный антидепрессивный и противотревожный ответ на психотерапию и назначение антидепрессанта в случае отказа от необходимого оперативного лечения у больной Б., 35лет, и/б № 558-89, на фоне остро развившегося тревожно-фобического эпизода, в основе которого лежал глубинный страх смерти. [4] После отказа от операции непосредственно перед её проведением, с больной была немедленно проведена психотерапев-

тическая беседа, и был предложен прием антидепрессанта с противотревожным радикалом действия. Через три дня приема препарата у больной снизился уровень аффективного напряжения, фон настроения стабилизировался настолько, что она на фоне сопутствующей «интенсивной психотерапии» смогла конструктивно подойти к решению вопроса о необходимости хирургического лечения, и через семь дней приема препарата и психотерапевтических интервенций больная была успешно прооперирована.

На четвертом этапе, послеоперационном, происходит облегчение, резко снижается степень выраженности всех отрицательных переживаний больных и происходит своеобразное «психологическое облегчение», а преобладающим психопатологическим синдромом становится астения, сочетающаяся с ипохондрической фиксацией на тех или иных ощущениях больного. Здесь требуется не только внимательно выслушивать и «обесценивать» ипохондрические жалобы, но и обращать, как-бы невзначай, внимание больного на любые положительные сдвиги в его состоянии, обсуждать с ним перспективы планов на будущую жизнь в формате вопроса: «что я буду делать, когда выздоровлю, поправлюсь и выпишусь из клиники». Такая стратегия подхода к выздоравливающим пациентам помогает закрепить у них позитивное жизнеутверждающее поведение, и установку на требуемое, зачастую, поддерживающее послеоперационное лечение. На катамнестическом этапе, около двух третей пациентов имеют особые, так называемые, субдепрессивные нарушения психического состояния [5]. Внешне они проявляются как нерезковыраженная подавленность и стремление к самоизоляции. Отношение к привычным и любимым прежде, развлечениям меняется, и порой становится резко негативным. Попытки со стороны близких людей как-то «расшевелить» больного, как правило, не имеют никакого успеха. Особенно отрицательное отношение вызывают те ситуации, которые связаны с силь-

ными эмоциональными переживаниями. Утрачивается интерес и к внутрисемейным делам. В переживаниях больного постоянно звучат депрессивные ноты, связанные не только с наличием онкологического заболевания, но и его последствиями — инвалидизацией, утратой привлекательности и т.п. Особенно болезненны переживания, относящиеся к интимной сфере. При обнаружении таких состояний на приеме, желательно направить такого больного к психиатру-психотерапевту, поскольку данные состояния на современном этапе можно успешно корректировать при помощи психотерапии и лечить антидепрессантами и анксиолитиками, применение которых в некоторых случаях бывает критически необходимым. Следует напоминать больному, что прогресс в изучении причин опухолевых заболеваний в последние годы, значительно улучшил прогноз на период ближайших 10 лет от момента постановки диагноза, а совершенствование хирургических методов лечения позволяет во многих случаях радикально излечить больного от опухоли. Таким образом: следует активизировать фактор вселения надежды на выздоровление, ориентировать больного на реалистично возросший потенциал онкологической науки и предостерегать от зачастую распространенного и иррационально обоснованного обращения к «народным методам», «народным целителям», которые, в итоге, оставляя больного без адекватного лечения, могут нанести непоправимый вред здоровью и жизни.

Отсутствие депрессии и максимальная вовлеченность пролеченного больного в жизнь семьи, коллектива и общества в целом, создаёт благоприятные предпосылки для успешной социальной реабилитации. Это позитивно сказывается на улучшении качества жизни больного и помогает вернуть человека на максимально адаптивный уровень социально-психологического функционирования для выполнения задач ставящихся обществом перед онкологической службой системы здравоохранения РК.

Список литературы

1. Нуллер Ю.Л. Структура психических расстройств.-Киев:Сфера, 2008.
2. Русина Н.А. Адаптационные ресурсы пациентов онкологической клиники //Bulletin of Medical Internet Conferences.- 2011.Vol.1.-P 92-94.
3. Бажин Е.Ф., Гнездилов А.В. О психогенных реакциях у онкологических больных / Журнал невропатологии и психиатрии.-1980.-№8.-С.1198-1204.
4. Артемьев К.В., Войновский Ю.В. // Онкология и радиология Казахстана.-2014.- №2 (32).- С. 46 – 49.
5. Володин Б.Ю., Петров С.С., Куликов Е.П. Психиатрия и психотерапия в онкологической практике. Учебное пособие // Ряз. гос. мед.ун-т им. акад. И.П.Павлова. – Рязань: РИО РГМУ, 2006. – С.83.

Тұжырым

К.В.Артемов, И.Р.Хусаинова

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

**Онкологиялық науқастарға психологиялық
қолдау көрсету**

Мақала психотерапиялық стратегиялар мен түрлі кезеңдерінде онкологиялық науқастарға психологиялық қолдауда психологиялық тәсілдерді қолданудың нақты мәселелеріне арналған. Қатерлі ісікпен ауыратын науқастарды психофармакологиялық қолдаумен ұштастыра психотерапия қолдану мысалдары қарастырылған. Онкологиялық бөлімінің жағдайында психологиялық жұмыс стратегиясын әзірлеу үшін нұсқаулар ұсынылады.

Түйінді сөздер: Онкология, онкопсихология, психотерапия, өмір сапасы.

Summary

K.A.Artemyev, I.R.Khussainova

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Psychological support of cancer patients

The article is devoted to specific issues of psychotherapeutic strategies and psychological approaches, accompanied by cancer patients at different stages. Examples of application of psychotherapy in combination with psychopharmacological support of patients with cancer. Recommended guidelines for developing strategies of psychological work in the conditions of the oncology department.

Keywords: Oncology, psychooncology, psychotherapy, quality of life.